

CONSULTATION

CADRE

- Se présenter :
 - Nom
 - Fonction
 - Nom du supérieur et lieu de travail
 - Serrer la main
- Utiliser un désinfectant avant et après le status
- Se placer à droite du patient lors du status
- [...]
- Résumer et énoncer les perspectives
- Serrer la main en prenant congé.

ANAMNÈSE

STRUCTURE DE L'ANAMNÈSE

1. Motif de consultation
2. Anamnèse actuelle
3. Antécédents personnels
4. Anamnèse personnelle
5. Antécédents familiaux
6. Anamnèse psychosocial
7. Anamnèse par système
8. Examen clinique (status) général et par système
9. Résumé : liste des problèmes, diagnostic différentiel, stratégie diagnostique et thérapeutique
10. Traitements

PRISE DE CONTACT

- Se désinfecter les mains
- Saluer : « *Bonjour* »
- Serrer la main
- Se présenter (prénom et nom) : « *Je m'appelle ...* »
- (Demander son nom et son âge)
- Inviter à s'asseoir si besoin
- S'assurer que le patient est disponible :
 - « *Est-ce que vous êtes à l'aise ?* »
 - « *Est-ce que vous m'entendez correctement ?* »
 - « *Est-ce que vous avez soif ? Est-ce que vous avez froid ?* »

MOTIF DE CONSULTATION

- « *Qu'est-ce qui vous amène ?* », « *Qu'est-ce que je peux peut faire pour vous ?* »
(Question la plus ouverte possible)
Le patient n'est pas nécessairement atteint dans sa santé (plainte souffrance), il peut demander une consultation pour faire un bilan de santé (on présume qu'il est en bonne santé).
- Ne pas interrompre le patient ; lui laisser tout le temps nécessaire pour répondre.

ANAMNÈSE ACTUELLE

RLQCCSMA8 : reformulation, localisation, qualité, chronologie, conditions, modifications, associations

- Préciser le motif de consultation :
 - Reformuler : « *Vous me dites que vous avez mal au ventre (?)* » « *[...], c'est-à-dire ?* »
 - ➔ Permet d'ordonner les réponses apportées par le patient.
 - ➔ Assure le patient de l'écoute du médecin.
 - Localiser : demander au patient de signaler le lieu de sa douleur (si nécessaire) :
« *Est-ce que vous pouvez me montrer où est-ce que vous avez mal ?* »
 - Qualité (serrement, colique, spasme, brûlure, décharge électrique, constriction, serrement, pression, sensation de déchirement, d'arrachement, aigue, en coup de poignard, brûlure, piqure d'aiguille, sourde) :
« *Comment se manifeste cette douleur ?* » « *Quel type de douleur ressentez-vous ?* » « *Est-ce une brûlure ? une pression ? un coup de poignard ? une sensation de déchirement ?* »
Utiliser des métaphores, des comparaisons : « *Est-ce que ça vous serre comme un casque ?* »
 - Intensité et irradiation :
« *Est-ce que cette douleur est homogène ?* » « *Est-ce que la couleur est toujours identique ?* »
« *Est-ce que cette douleur est la même partout ?* » « *Est-ce que cette douleur se propage ?* »
 - Définir la chronologie (début, fin, durée, fréquence) :
« *Quand est-ce que vous avez mal ?* » « *Pendant combien de temps avez-vous mal ?* » « *Quand est-ce que la douleur se termine ?* » « *Combien de fois se manifeste cette douleur ?* »
 - Conditions de survenue : aucune, effort, froid, stress, respiration, toux, mouvements du tronc, repas riche, se pencher en avant, au coucher, déglutition d'aliment) :
« *Quand est-ce que cette douleur apparaît ?* »
 - Facteur modifiant le symptôme : repos, soulagée en position assise, aggravée en position couchée, prise de médicaments :
« *Est-ce qu'il y a des facteurs/des circonstances qui modifient cette douleur ?* »
 - Manifestations associées : douleur, dyspnée, nausée, vomissements, toux, sueurs, syncope, paralysie, dysphagie, plaintes diffuses :
« *Est-ce que vous ressentez d'autres manifestations ?* »

ANTÉCÉDENTS PERSONNELS

MATOA6 : Maladies, allergies, traitements, opérations, accidents, hospitalisation

Informez le patient que l'on va aborder ses antécédents : « Je vais vous demander quelques informations sur votre état de santé. »

- Les maladies et leurs traitements
« Est-ce que vous souffrez/avez souffert d'autres maladies ? » « Lesquels ? »
- Les accidents et les blessures
- Les opérations
- Les hospitalisations
« Est-ce que vous vous êtes déjà rendu chez un autre médecin ? » « Est-ce que vous avez déjà été hospitalisé ? » « Est-ce que vous avez subi une opération ? » « Pour quelles raisons ? »
- Chronologie, circonstances, médecins, hôpitaux
- Allergies :
« Est-ce que vous souffrez d'allergies ? » « Avez-vous réalisé des tests ? »
- Médicaments :
« Est-ce que vous suivez un traitement ? » « Quel traitement suivez-vous ? » « Qui est-ce qui vous a prescrit ce traitement ? » (« Pour quelle raison et depuis quand ? »)

ANAMNÈSE PERSONNELLE

GVEEAR6 : général, vaccination, environnement, exercice, alimentation, risque, sexualité

Informez le patient que vous souhaitez aborder ses antécédents : « Je vais vous poser quelques questions sur votre vie personnelle. »

- Etat général ressenti par le patient
- Les vaccinations
« Est-ce que (à votre connaissance), vous vous êtes fait vacciner ? Quels vaccins ? »
« Pour quelle raison vous êtes-vous fait vacciner ? »
- Les risques liés à l'environnement :
 - Habitat : « Où est-ce que vous habitez ? »
 - Zone à risque : « Est-ce que vous êtes proches d'une zone à risque (chimique, sismique, stagnation d'eau, égouts) ? »
 - Exposition : « Est-ce que vous êtes exposés à des produits toxiques ? »
- Exercice, loisirs et voyage
« Que faites-vous de votre temps libre ? »
« Est-ce que vous pratiquez du sport ? Quel type ? Quelle fréquence ? »
- Habitudes alimentaires :
« Est-ce que vous arrivez à vous nourrir correctement ? »
« Quel est votre poids ? » « Comment évolue votre poids ? » (constant ou variable)
« Est-ce que vous avez des problèmes lorsque vous vous rendez aux toilettes ? »
- Facteur de risques : alcool, tabac, substances toxiques
- Sexualité

ABORDER LES FACTEURS DE RISQUES

- Prévenir et rassurer :
« C'est une question de routine : ... »
« Est-ce que vous consommez d'autres substances ? »
- Consommation :
 - Tabac : « Est-ce que vous fumez ? Quel type (cigarette, ...) ? A quelle fréquence ? »
 - Alcool : « Est-ce que vous buvez de l'alcool ? » « Quelle est votre consommation d'alcool ? » (modérée ?) « Quelle est la fréquence ? »
 - Drogues :
« Est-ce que vous avez déjà consommé une drogue (forte) ? »
« Est-ce qu'il vous arrive encore d'en consommer ? Quelle fréquence ? Quel type ? »
- Déterminer l'incidence :
« Est-ce cette consommation a des répercussions sur votre vie (de tous les jours) ? »
- Arrêt : « Est-ce que vous avez déjà pensé à arrêter ? »
- Conseiller et donner des perspectives

ABORDER LA SEXUALITÉ

Cf. anamnèse sexuelle

ANTÉCÉDENTS FAMILIAUX

DRHM₄ : décès, risque, héréditaire, maladie

Informez le patient que vous souhaitez parler de sa famille : « Je souhaiterais vous poser quelques questions sur votre famille. ».

- Pathologies retrouvées dans la famille :
 - Pathologies (et causes de décès) des parents (à quel âge?)
 - Pathologies des frères et sœurs (à quel âge?)
 - Pathologies chez les enfants
- Décès :
« Comment se portent vos parents ? »
« Quelle est la cause de décès de vos proches ? »
- Facteurs de risque :
« Est-ce que vos proches fumaient ? »
« Est-ce qu'ils avaient des problèmes d'alcool ou de drogue ? »
- Maladie héréditaire :
« Est-ce que vous ou vos proches êtes porteurs, à votre connaissance, d'une maladie héréditaire ? »
« Est-ce que vous êtes porteur d'une maladie génétique ? »
- Affection actuelle :
« Est-ce que un de vos proches a déjà présenté les symptômes que vous présentez actuellement ? »

ANAMNÈSE PSYCHOSOCIALE ET PROFESSIONNELLE

Informez le patient que vous souhaitez, à nouveau, de lui de lui et son état d'esprit : « J'aurai encore besoin de quelques informations... ».

- La situation sociale (état civil, vie de famille) :
 - Famille : « *Quel est votre état civil ?* » « *Avez-vous des enfants ?* » « *Est-ce que vous les voyez fréquemment ?* » (permet de déterminer le type de relation et savoir si on peut les contacter en cas d'urgence)
« *Comment se déroule votre vie de couple/famille ? (Est-ce que ça se passe bien dans votre famille ?)* »
- La vie au quotidien (déroulement de la journée) :
« *Comment se déroule votre journée ?* »
- L'activité professionnelle :
« *Est-ce que vous avez une activité professionnelle ?* » « *Laquelle ?* »
- Le parcours de vie
- Les croyances religieuses
- Impact de la douleur :
 - Chercher le degré d'impact :
 - « *Quel est l'impact de cette douleur dans votre vie ?* » (sentimental, travail)
 - « *Est-ce que vous dormez bien ?* »
 - « *Est-ce que vous vous sentez affaibli ?* »
 - « *Comment est-ce que vous vous sentez au niveau de l'humeur ?* »
 - « *Quel est l'impact de cette douleur dans votre vie ?* »
 - « **Comment gérez-vous cette situation ?** »
 - « **Est-ce que ça vous inquiète ?** »
 - « **Est-ce que ça vous pèse ?** »
 - Variation de la douleur :
 - « *Quand est-ce que cette douleur augmente/diminue ?* »
 - « *Est-ce que ces conflits génèrent du stress ?* »
 - « *Quand, où, est-ce que cette douleur se soulage ?* »
 - NB : Si la douleur augmente, elle peut aussi diminuer. Insister sur la **variabilité** !
 - Perspectives :
 - « *Qu'est-ce que vous ferez aller mieux ?* »
 - « **Dans quelle situation vécue, vous êtes-vous senti mieux/à l'aise ?** »
 - « *Est-ce que vous avez besoin de soutien ?* »
 - « *Est-ce que vous vous sentez dans le besoin de parler à quelqu'un ?* »
 - « *Est-ce que vous en avez parlé avec vos proches ?* »
 - « *Est-ce que vous vous sentez soutenu par votre entourage (dans votre maladie) ?* »
 - « *Est-ce que vous avez déjà essayé de vous faire aider ?* »
 - « *Est-ce que vous avez été suivi par un psychothérapeute ?* »

ANAMNÈSE PAR SYSTÈME

Pour tout symptôme pathologique, se renseigner sur la :

- Localisation
- Qualité
- Intensité
- Situation et survenue
- Facteurs aggravant et soulageant
- Réponse au traitement

ANAMNÈSE GÉNÉRALE

- Paramètres :
 - Etat général
 - Poids (évaluer perte, gain, cinétique) ? Perte d'appétit? Asthénie?
 - Température (mesurée)? Etat fébrile? Frisson? Sudations (nocturnes) ?
 - Adénopathies
 - Allergies

+ demander si bruits respiratoires quand reprise du souffle ; demander si expectorations à l'effort

- Cardiaque :
 - Dyspnée? Quel degré? Orthopnée ? Dyspnée paroxystique nocturne? Quel degré?
« Avez-vous de la peine à respirer? »
 - Douleur rétro-sternale ?
« Ressentez-vous une douleur ou une gêne à la poitrine? »
 - Œdèmes des membres inférieurs ?
« Avez-vous déjà eu un gonflement quelque part? Vos chaussures/vos bague/votre ceintures sont-elles devenues trop serrées? »
 - Palpitations (perception désagréable des battements cardiaques)?
« Vous arrive-t-il de percevoir les battements/les accélérations de votre coeur? A que cela ressemble-t-il? » -> Demander au patient de battre le rythme avec une main ou un doigt
 - Syncope
« Avez-vous perdu connaissance récemment? »
 - Cyanose
 - Nycturie

Pour syncope : demander combien de temps et dans quelle situation.

Pour nous : 4 stades de dyspnée :

I : ø de limitation

II : Effort important

III : Effort modéré

IV : Au repos

ECHELLE DE DYSPNÉE DU MRC

- Degré 1 : patient avec dyspnée lors d'un exercice intense.
- Degré 2 : dyspnée lors d'une marche rapide sur terrain plat ou en montant une pente légère.
- Degré 3 : marche plus lentement que les personnes de son âge sur terrain plat, ou doit s'arrêter pour respirer lorsqu'il marche à son propre rythme sur terrain plat.
- Degré 4 : doit s'arrêter pour respirer après une marche d'environ 90 mètres.
- Degré 5 : trop essoufflé(e) pour quitter la maison, ou dyspnée lors de l'habillement.

DOULEUR RÉTROSTERMALE

- Respiro-dépendante : pneumothorax, péricardite, embolie pulmonaire
- Au toucher: atteinte musculo-squelettique
- Permanente : infarctus

- Pulmonaire :
 - Dyspnée ?
 - Douleur thoracique ?
 - Toux ? Depuis combien de temps ?
 - Ronflements
 - Expectorations :
 - Quantité : petite quantité ? abondamment ?
 - Couleur : rouge (**hémoptysie**) ? verdâtre ? transparente (glaires) ?
- Abdominale :
 - Dysphagie (liquides, solides) ?
 - Nausées, vomissements ?
 - Douleurs abdominales ? Pyrosis ?
 - Réplétion gastrique ?
 - Selles : fréquence ? Qualité ? **Sang** ? Couleur ? Odeur ? Incontinence ? Gaz ?
 - Ictère

RESPIRATION

- Effort (respiration difficile non angoissante) <- effort musculaire
- Suffocante, angoissante <- BPCO, insuffisance cardiaque
- Serremment, poitrine serrée <- asthme et fibres vagues

	Douleur viscérale	Douleur somatique
Neurologie	sympathique + parasymphatique	nerfs spinaux
Origine	infiltration, étirement spasme, ischémie	paroi abdominale (péritoine pariétal incl.)
Caractère	mate, profonde, térébrante, colique	aigue, brûlante
Localisation	difficile	précise
Symptômes végétatifs associés	fréquent	rare

Schmerztyp	Diagnose			
 Perforation	 Ulcusperforation	 Mesenterialinfarkt	 Gallenblasenperforation	
 Kolik	 Gallenkolik	 Uretersteinkolik	 Ileus	
 Entzündung	 Appendizitis	 Pankreatitis	 Cholezystitis	

Bristol Stool Chart		
Type 1		Separate hard lumps, like nuts (hard to pass)
Type 2		Sausage-shaped but lumpy
Type 3		Like a sausage but with cracks on the surface
Type 4		Like a sausage or snake, smooth and soft
Type 5		Soft blobs with clear-cut edges
Type 6		Fluffy pieces with ragged edges, a mushy stool
Type 7		Watery, no solid pieces. Entirely Liquid

- Urinaire :
 - Dysurie (difficulté à l'évacuation de l'urine) ?
 - Diminution de la force du jet ?
 - Pollakiurie (fréquence excessive des mictions) ?
 - Incontinence
 - Algurie (douleurs et brûlures à la miction) ?
 - Douleurs et crampes dans le bas ventre ? dans le dos ?
 - Couleur de l'urine ? Jaune ? Brune ? Rouge ?

- Neurologique :
 - Vertiges ?
 - Céphalée ? Raideur de nuque ?
 - Troubles visuels? Diplopie ? Photophobie ?
 - Trouble de l'audition ? Hypoacousie?
 - Troubles moteurs ? Diminution de la force ?
 - Troubles de la sensibilité ? Diminution de la sensibilité? Paresthésies?
 - Troubles de l'équilibre? Trouble de la marche?
 - Douleurs (décharge électrique, brûlure) ?
 - Troubles cognitifs (Mini Mental State)

ANAMNÈSE GÉNÉRALE ÉCRITE

[...] : à compléter

.../... : choisir selon l'individu

En gris : selon le status, ne doit pas figurer obligatoirement sur le rendu écrit.

Anamnèse

Il s'agit d'un/une patient/patient de [âge] ans, connu/connue pour une/des [antécédents pertinents pour la prise en charge] qui [consulte aux urgences/qui est adressé par son médecin généraliste] pour une [signe/symptôme principal] apparue il y a [description temporelle]. Monsieur/Madame se plaint [description détaillée de la plainte : anamnèse actuelle].

[...]

Les reste de l'anamnèse n'est pas contributive.

Status écrit

Paramètres : [TA] mmHg, [FC] bat/min, [Température] °C, [Sat] %, orienté/orientée aux 3 modes, [glycémie]

CV : rythme normo/brady/tachy-carde irrégulier/régulier avec B1-B2 bien frappés/lointains, souffle [description]/sans bruits surajoutés, bonne perfusion périphérique avec tous les pouls distaux palpables/malgré des pouls distaux non palpés, turgescence/oedème/reflus hépato-jugulaire présent

Pulm : murmure respiratoire présent et symétrique /râles crépitants aux deux bases.

Abdo : abdomen souple et indolore/défense et détente abdominales, bruits normaux en tonalité et en fréquence, loges rénales souples et indolores/sensibles et douloureuses, percussion douloureuse, toucher rectal

Neuro : GCS de [...]/orienté/e aux 3 modes/bien éveillé/collaborant, pupilles isocores et isoréactives, NC (III - XII) sans particularités, sensibilité présente/préservée/diminuée/absente et symétrique/conservée aux 4 membres, M[échelle de force] aux 4 membres, ROT et cutané-plantaire normo/hypo-vif et symétrique, marche non testée, diadococinésie et dysmétrie sans particularités, rigidité/spasticité, signes méningés, bras-tendu/Romberg/talon-genou/rebond sans particularités

ANAMNÈSE GÉNÉRALE RAPIDE

Par système :

- Cardio-pulmonaire :
 - Dyspnée ? (*mal à respirer*) -> Si oui : orthopnée ?
 - Toux ?
 - Crachats ? -> Si oui : aspect ? + syncope
 - Douleurs thoraciques ?
 - Palpitations ? (*cœur bat plus vite*)
 - Œdèmes ? (*jambes gonflées*)
- Digestif :
 - Diarrhée ? (*fréquence des selles*)
 - Date des dernières selles ?
 - Sang ou selles noires ?
 - Nausées ? Vomissements ?
 - Mal au ventre ?
- Urologique :
 - Urine plus fréquemment ?
 - Douleurs lorsqu'il urine ?
 - Sang dans les urines ?
- Neurologique :
 - Céphalée
 - Pertes de force, de sensibilité, de la coordination, de la marche ?
 - Vertiges (*tête qui tourne*)

Etat général :

- Fièvre
- Poids
- Transpiration

Pathologie thoracique urgente : dissection aortique ; infarctus du myocarde ; oedème pulmonaire ; tamponnade ; embolie pulmonaire ; pneumothorax.

Douleurs thoraciques non cardio-pulm : Les douleurs oesophagiennes : Reflux gastro-oesophagien, spasme de l'oesophage, rupture de l'oesophage (rare)

ENTRETIEN MOTIVATIONNEL

INTRODUCTION

La façon dont nous nous adressons à un patient par rapport à sa santé peut influencer sa motivation à changer son comportement.

L'entretien motivationnel est une technique qui vise à aider le patient à changer son comportement. Il se fonde sur l'idée qu'une personne n'arrivera à des changements que si la motivation vient de la personne elle-même. Son but est donc de susciter et renforcer cette motivation.

PLAN

1. DEMANDER LA PERMISSION

- « *Seriez-vous d'accord que l'on discute un moment de... ?* »
- « *Est-ce que vous seriez d'accord que l'on discute (un petit moment) des facteurs de risque – ces choses qui ne sont pas bonnes pour la santé – pour ... ?* »

2. HISTORIQUE

- Inviter le patient à élaborer, à participer en lui demandant de raconter son histoire.
« *Parlez-moi un peu de votre consommation de ...* »
« *Racontez-moi un peu comment vous avez commencé à ... / comment est apparu votre... ?* »
- Développer à partir des connaissances du patient

INFORMER ET CONSEILLER

(Pas toujours nécessaire)

- Identifier les connaissances du patient : « *Que savez-vous déjà de ... ?* »
- Identifier les besoins du patient : « *Que souhaitez-vous savoir à propos de ... ?* »
- Informer : compléter, ajuster, fournir l'information/les conseils de façon neutre
TOUJOURS DEMANDER : « *Vous avez raison et je me rends compte que vous savez beaucoup de choses. Est-ce que vous seriez d'accord que je vous donne davantage d'informations ?* »
- Explorer ce que le patient a compris et les implications : « *Qu'est-ce que vous en pensez ?* » « *Que faites-vous de cela ?* » « *Qu'est-ce qui a été utile ?* » -> Le patient doit s'approprier cette information

3. EXPLORER LES AVANTAGES ET LES INCONVÉNIENTS

Questions types :

- « *Qu'est-ce qui vous semble difficile/pénible avec ... ?* »
- « *Qu'est-ce qui vous dérange avec ... ?* »
- « *Parlez-moi de vos craintes par rapport à ... ?* »

- « *Qu'est-ce qui est (malgré tous les problèmes que vous avez aujourd'hui) ok/bien avec ... ?* »
- « *Quelles sont les bonnes choses/les avantages de la situation actuelle ?* »
- « *Qu'est-ce que ça vous apporte/vous amène ?* »
- « *Que voyez-vous encore ?* »

Style de communication : **Suivre**

- But :
 - Laisser le patient exprimer vécu émotionnel afin de mieux comprendre le patient -> bien comprendre permet de mieux aider.
- Comment ? Ecoute centrée sur le patient :
 - (Demander la permission)
 - Laisser exprimer
 - Ecouter
 - Répéter, paraphraser et refléter -> approfondissement des émotions du patient

4. EVOQUER ET RENFORCER LE CHANGEMENT

Questions types :

- « *Je vous propose d'imaginer/ imaginez que vous déjà pris la décision de faire quelque chose par rapport à Quels seraient les gains potentiels, les bénéfices, les aspects positifs ?* »
- « *Qu'est-ce qui serait différent par la suite si vous arriviez à changer ces comportements/ si les choses changeaient ?* »
- « *Si vous deviez atteindre cet idéal, qu'est-ce qui se modifierait par la suite ?* »

Style de communication : **Guider**

- But :
 - Evoquer et renforcer une motivation à changer de comportement. Pourquoi évoquer le changement ?
 - L'évocation du changement permet au patient de verbaliser les avantages d'un changement et de lui donner envie de l'atteindre. Le but est d'augmenter la motivation du patient en lui faisant explorer ce qui pourrait être mieux dans sa vie.
 - Attention, il est important ça soit le patient qui évoque le changement et élabore les pistes pour l'atteindre.
- Comment ?
 - Écoute empathique ciblée
 - Favoriser l'exploration de la situation
 - Evocation du changement -> utiliser le conditionnel : le conditionnel permet d'explorer le changement sans se sentir contraint de s'y engager et sans que son exploration ne soit limitée par des blocages éventuels (craintes, difficultés).
 - Reflets sélectifs (pour que la réflexion suive une direction particulière) -> Quelle direction ? : **renforcer les aspects du changement**
 - Augmenter l'importance que le patient accorde au changement individuel.

« Permettez-moi de chiffrer des choses qui ne sont pas chiffrables comme si on utilisait un thermomètre. Quelle serait l'importance pour vous d'effectuer ce changement/ de changer sur une échelle de 0 à 10 (= étant pas du tout important et 10 très important) ? Comment vous situez-vous ? »

« Qu'est-ce qui vous fait dire 7 plutôt que 4 ? »

« Pourquoi le changement est si important ? »

- Augmenter la confiance du patient dans sa capacité à atteindre le changement.

« Si vous décidiez d'effectuer ce changement, quelle serait la confiance que vous auriez en votre capacité de réussir sur une échelle de 0 à 10 ? »

« Qu'est-ce qui vous fait dire 4 plutôt que 1, par exemple ? Comment cette confiance pourrait passer de 4 à 7 ? »

« Comment votre confiance pourrait se renforcer ? »

- Utiliser le discours-changement.

LES OUTILS

L'ALLIANCE THÉRAPEUTIQUE

- Comment créer l'alliance thérapeutique ?
 - Méthode : utiliser l'empathie pour créer un climat de confiance et éviter toute confrontation.
 - Attitude : bien connaître les produits d'addiction tout en adoptant une position d'écoute.
 - But : pointer les contradictions entre les bénéfices ressentis sous produits et les conséquences inéluctables sur la vie personnelle sans confrontation. L'objectif n'est pas de convaincre mais de restituer un bilan le plus fidèle possible de la situation afin de provoquer une prise de conscience.

L'ÉCOUTE RÉFLECTIVE

- Définition : l'écoute réflexive permet de vérifier la communication soignant – patient (de vérifier si ce que le soignant pense que le patient a dit est bien ce que le patient a voulu dire) et de tester des hypothèses (formulée sous forme d'affirmation). Le but est de compléter les informations en reformulant ou en confrontant et d'explorer l'envie et les obstacles au changement.
- Méthodes :
 - Reflet simple (RS) :
 - Affirmation neutre qui est une reformulation d'une phrase verbalisée par le patient.
 - Reflet complexe (RC) :
 - Affirmation qui interprète et verbalise l'émotion sous-jacente du discours de patient et qui confronte le patient à une contradiction ou à une vérité (une émotion qu'il ignore).
 - Reflet de sentiment (RdS) :
 - Affirmation empathique qui interprète et verbalise un sentiment (sous-jacent du discours de patient) afin de susciter une réflexion chez le patient (voire une confrontation) et créer un rapprochement soignant – patient.
- Exemples :
 - 1^{er} exemple : « Ca me dérange terriblement d'avoir ces coups de pompes car ça me fait dormir. Ca m'ennuie car lorsque je rentre à la maison, j'ai beaucoup de chose à faire. Parfois, en fin de journée, j'ai envie de boire un petit apéritif. J'ai l'impression que ça va me donner du courage pour continuer à fonctionner. »
 - RS : « L'alcool vous donne du courage. »

- RC : « L'alcool vous donne du courage mais en même temps il est à l'origine de votre fatigue et de vos coups de pompes »
- RdS : « J'ai le sentiment/l'impression que vous vous sentez tiraillé entre les différents effets de la consommation d'alcool. D'un côté l'alcool vous donne du courage et de l'autre côté il vous fatigue. Vous devez vous sentir un peu perdu. »
- 2^{ème} exemple : « Ce qui me paraît pénible avec mon poids ?! Il y a l'aspect social : la manière de se présenter aux autres, le jugement que certains semblent exprimer par leur attitude. Il y a une forte pression sur le paraître... Mais aussi des choses plus personnelles : le fait de se déplacer avec plus de difficulté, d'être essoufflé. Ce genre de chose... »
 - RS : « J'entends bien/ je comprends bien que votre poids actuel vous gêne à cause du regard des autres, qui peut parfois être jugeant, et aussi parce que vous vous déplacez plus difficilement et que vous êtes essoufflé. »
 - RC : « Le regard des autres, leurs jugements, votre peine à vous déplacer, votre inconfort vous indiquent, voire vous incitent peut-être, à vouloir modifier quelque chose dans votre situation actuelle. »
 - RdS : « J'ai l'impression que vous subissez/souffrez du regard des autres et des répercussions plus personnelles de votre poids. »
- Modèle d'échange d'informations :
 - Faire évoquer :
 - « Que savez-vous au sujet de... ? »
 - « Que voulez-vous savoir à propos de... ? »
 - « Seriez-vous d'accord que je vous explique... ? »
 - Informer :
 - Donner l'information en s'assurant d'en avoir la permission.
 - Parler de ce qui marche pour d'autres.
 - Donner des choix.
- Faire évoquer :
 - « Que faites-vous de cela ? »
 - « Qu'est-ce qui pourrait être utile pour vous ? »

LE DISCOURS-CHANGEMENT

- Définition : tous les propos du patient qui expriment sa motivation à changer/ tout ce qui est dit par le patient en faveur du changement.
Il dépend de l'importance que revêt le changement aux yeux du patient ou de la confiance qu'il a en sa capacité à le réaliser.
 - Discours-maintient : tous les propos du patient qui expriment sa motivation à ne pas changer. <- à éviter !
- Méthode :
 - Reconnaître le discours-changement :
 - Désir : « J'aimerais bien arrêter de fumer. »
 - Besoin : « Je dois absolument perdre du poids. »
 - Raison : « Je dois changer, car ma femme ne me supporte plus comme ça. »
 - Capacité : « Je sais que si je le veux vraiment, je suis capable de tenir bon. »
 - Renforcer le discours-changement :
 - Elaboration : « Comment pourriez-vous vous y prendre ? »
 - Reflet
 - Valorisation : « Vous vous sentez assez fort pour réussir à tenir bon. »
 - Résumé

- Attention, il ne s'agit pas de nier le discours-maintien, de nier le plaisir que peut apporter l'addiction. Au contraire, il est important de légitimer ce plaisir. L'astuce réside de commencer en légitimant le discours-maintien puis d'insister davantage sur le discours-changement.

LES BARRIÈRES

RÉFLEXE CORRECTEUR

- Définition : tendance des professionnels de la santé à vouloir réparer les problèmes de leurs patients.
- Mécanismes :
 - Convaincre le patient qu'il a un problème : « *Vous avez un problème avec l'alcool ; vous buvez trop.* »
 - Argumenter en faveur des avantages du changement : « *Si vous arrêtez de boire, vous serez plus disponible pour votre famille.* »
 - Mettre en garde contre les risques de ne pas changer : « *Si vous continuez à boire, vous allez perdre votre travail.* »
- L'être humain a tendance à résister à la persuasion. Le patient exprime de la résistance face au réflexe correcteur. Il est important d'en être conscient et d'éviter tout réflexe correcteur.

AMBIVALENCE

- Définition : attitude normale qui accompagne le changement de comportement caractérisée par une volonté simultanée de vouloir changer et de ne pas changer.
- Mécanisme : la plupart des gens veulent être en bonne santé et veulent agir dans ce sens, mais en même temps, ils se sentent bien avec leurs habitudes et voient des inconvénients à les changer.
- Le soignant ne doit pas contrer l'ambivalence du patient. Au contraire, il doit accepter l'ambivalence sans jugement et ne pas essayer de le pousser à aller dans un sens ou un autre.

RÉSISTANCE

- Définition : opposition naturelle du patient à l'argumentation du soignant en faveur du côté « santé » de l'ambivalence, qui s'exprime par une argumentation en faveur de l'autre côté, une tendance à relativiser et un entêtement.
- La résistance étant fortement influencée par l'attitude du soignant, son apparition, indique au soignant qu'il doit la changer ; le rôle du soignant est de diminuer la résistance du patient.

ANNONCE DE MAUVAISES NOUVELLES

ENTRETIEN D'ANNONCE DE MAUVAISES NOUVELLES

OBJECTIFS

- Evaluation du niveau de connaissance et des attentes du patient;
- Soutien au patient à l'aide des compétences relationnelles et de l'empathie;
- Permettre l'expression des émotions;
- Elaboration des stratégies de traitement et/ou d'accompagnement possible.

ETHIQUE

Le respect du principe d'autonomie du patient implique :

- De tenir compte du contexte biographique de la personne malade;
- D'intégrer dynamique familiale;
- D'informer le patient et ses proches d'une façon aussi claire et aussi franche que possible;
- De s'assurer que les informations aient été bien comprises;
- De veiller à ce que la volonté de la personne malade soit bien comprise et dans la mesure du possible prise en compte;
- D'orienter les décisions selon les valeurs et les volontés exprimées au préalable, oralement ou par écrit, par le patient incapable de discernement (p.ex. directives anticipées).

QU'EST-CE QU'UNE MAUVAISE NOUVELLE POUR UN PATIENT?

Une information qui affecte inéluctablement et sérieusement la vision du futur d'une personne.¹

EPICES

E COMME ENVIRONNEMENT

Objectifs : préparation de l'environnement extérieur et des dispositions intérieurs des soignants.

1. Préparation de l'entretien :
 - Relire le dossier;
 - Répartir le temps de parole et les objectifs à réaliser entre les différents intervenants;
 - Anticiper les réactions émotionnelles possibles;
 - Prévoir un endroit intime.
2. Saluer et se présenter : « *Bonjour, je suis [prénom et nom], [fonction].* »
3. Créer le cadre de l'entretien : « *Voilà, nous avons 45 min pour faire le point au sujet de...* »

¹ Buckman, R. (1994). *S'asseoir pour en parler*. Paris. InterEditions

P COMME PERCEPTION DU PATIENT (OU DES PROCHES)

Objectif : explorer ce que le patient a intégré de sa situation de manière à pouvoir ajuster l'information que l'on souhaite donner.

4. Explorer les connaissances du patient :

L'information qu'il a déjà reçue et qu'il a comprise : « *Pouvez-vous me dire, en quelques mots, ce que vous avez compris jusqu'à présent de votre situation ?* » « *Quelles informations avez-vous déjà reçues ?* » « *Savez-vous pour quelle raison cet examen a été réalisé ?* » « *Est-ce que vous me suivez jusque-là ?* »

- Les personnes rencontrées : « *Quels sont les médecins qui vous ont suivi ?* »
- Les représentations qu'il a de cette maladie et de ses conséquences : « *Pour vous, c'est quoi un cancer ?* »
- Les expériences personnelles (famille, proches) qu'il a de cette maladie et de ses conséquences : « *Vos proches ont également souffert de cette maladie ?* »
- Ce qu'il souhaite savoir, aujourd'hui : « *Qu'est-ce que vous attendez de la consultation d'aujourd'hui ?* »

5. Identifier et tenir compte des craintes, des attentes et des mécanismes de défense du patient.

I COMME INVITATION

Objectifs : vérifier si le patient souhaite être informé de « la mauvaise nouvelle » et ainsi pouvoir évaluer les capacités du patient à entendre ce qui doit lui être dit et de respecter son rythme.

Concéder au patient la possibilité de nommer et de mettre des limites permet de renforcer la mise en place de stratégie de coping.

6. Identifier les connaissances que le patient souhaite recevoir : « *Qu'aimeriez-vous savoir à propos de ce qui vous arrive ?* » « *Quel niveau d'information souhaitez-vous ?* » « *Avez-vous plutôt besoin de beaucoup de détails sur votre situation, ou alors une image plutôt globale ?* »
7. En cas de refus (d'informations), explorer les raisons afin d'assurer un accompagnement adapté lors des prochaines rencontres : « *Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas savoir davantage ; la plupart des patients veulent savoir plus ?* »

C COMME CONNAISSANCES

Objectifs : annoncer la mauvaise nouvelle

8. Prévenir le patient : « *Nous aurions voulu vous annoncer de bonnes nouvelles, mais malheureusement la situation est plus compliquée.* »
9. Donner l'information graduellement: « *Je vais vous annoncer quelque chose difficile.* »
10. Annoncer la mauvaise nouvelle: « *Les résultats des examens nous indique que vous souffrez...* »
11. Laisser ensuite un temps de silence pour évaluer sa réaction.

Techniques :

- Laisser constamment un temps de silence pour évaluer les réactions du patient et de son entourage en s'ajustant à leur niveau de compréhension.
- S'assurer de la compréhension : « *Est-ce que vous me suivez ?* »

- Utiliser un langage accessible et éviter tout jargon médical (mais nommer la maladie par son nom : cancer et non pas grosseur).
- Faire preuve d'honnêteté même si le diagnostic est sombre, et d'éviter les formulations de type « *il n'y a plus rien à faire* ».
- Une mauvaise nouvelle crée un état de choc diminuant ainsi sa capacité à mémoriser et à saisir l'information. Pour y remédier, il faut:
 - Répéter et revenir sur certains éléments.
 - Laisser place aux questions potentielles.
 - Générer des silences «invitants» ou «compassionnels» qui permettent au patient d'exprimer ses émotions et l'aide ainsi à mieux intégrer l'information.

E COMME EMPATHIE

Objectifs: accueillir les réactions émotionnelles

12. L'empathie est attitude relationnelle qui permet de l'autre dans sa souffrance en identifiant son émotion, la cause de celle-ci, et de lui offrir une validation sociale de son vécu. Faire preuve d'empathie permet d'accueillir les réactions émotionnelles.
« *Vous semblez totalement abattu par cette nouvelle!* » (identification) « *Et c'est tout à fait compréhensible...* » (validation) « *Je comprend votre peine et votre souffrance* ». Il faut assurer au patient sa que l'on est là pour lui : « *Je suis là* ». « *Je vais (essayer de) vous aider* ».
13. **Eviter la fausse réassurance** (Vous avez de multiples métastases cérébrales, mais rassurez-vous, on peut irradier et tout ira bien) doit absolument être évitée. C'est un moment d'émotions souvent intenses à partager sans autre intention que celle d'être là pour l'autre.

S COMME STRATÉGIES ET SYNTHÈSE

Objectifs: explorer les perspectives

14. Evaluer avec le patient s'il est prêt à poursuivre l'entretien ou s'il préfère le différer (élaborer un permet de diminuer l'anxiété): « *Je vous propose d'explorer un peu ce qui va se passer ces prochains jours, est-ce que vous en avez envie ? Je comprends bien que c'est un moment difficile pour vous mais parler des prochaines étapes peut peut-être vous soulager ?* »
15. Identifier les ressources du patients et les soutenir: « *J'ai bien conscience que la situation actuelle est difficile. Je voudrais savoir comment vous avez fait par le passé pour affronter les problèmes?* »
 - Stratégies de *coping* (-> recentrer sur le présent et faire surgir une attitude pro-active) : « *Qu'est-ce qui est important pour vous maintenant ?* » « *Qu'est-ce que vous pensez faire maintenant ?* »
 - Soutien extérieur: « *Qu'est-ce qui vous soutient aujourd'hui ?* » « *Quels sont les proches sur qui vous pouvez compter ?* » « *Vous voulez que j'appelle quelqu'un?* »
16. Présenter le plan de soins, traitements. Aborder les prochaines étapes médicales permet que le patient ne se sente pas abandonner.
17. Synthèse du contenu, reprise des éléments et réponses aux questions émergentes ou aux propositions concrètes.
18. Donner des délais, des étapes et fixer un prochain RDV pouvoir reprendre les éléments incompris et répondre aux questions qui émergent fréquemment à distance de l'annonce.

EXAMENS

ANAMNÈSE SEXUELLE

- Entretien exploratoire: L'anamnèse sexuelle est difficile pour le patient et le médecin car elle aborde l'intimité du patient, les représentations et les émotions du patient et du médecin
 - Justifier le nécessité de l'anamnèse et prévenir le patient:
 - « Pour compléter/terminer, il faut que je vous pose des questions plus intimes... »
 - « On sait que plusieurs facteurs peuvent affecter la sexualité, c'est pour cela que je me permet de vous poser quelques questions sur votre vie intime »
 - « Ce sont des questions délicates qui peuvent engendrer une certaine gêne, est-ce que ça vous pose problème ? »
 - Rassurer et mettre en confiance le patient:
 - « Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez me faire confiance ; je suis soumis au secret médical. »
 - « Je ne suis pas là pour vous juger. Je suis là pour vous aider. »
 - « Est-ce que ça vous fait du bien d'en parler ? »
 - « Si vous sentez mal-à-l'aise, dites-le-moi et, on passe à autre chose. »
 - Ouverture et autorisation :
 - « Est-ce que vous êtes d'accord que je vous pose des questions sur votre sexualité ? »
 - Nommer le climat émotionnel :
 - « Je vois bien que ça vous touche/gêne »
 - « Si les questions vous gênent, vous n'êtes pas obligé de répondre. Mais ça peut m'aider à comprendre où vous en êtes dans votre santé ».
 - Utiliser un langage adapté: signification des mots
 - Investigation ≠ inquisition

Symptômes -> caractéristiques -> contexte -> biographie

- Motif de consultation:
 - Question ouverte :
 - « Etes-vous satisfait de votre sexualité ? »
 - « Comment est-ce que vous vivez votre sexualité ? »
 - « Comment se déroule votre vie sexuelle ? »
 - Si la personne est gênée, énoncer des questions fermées : nombre de partenaire, fréquence des rapports, comportements à risque :
 - « A quelle fréquence avez-vous des rapports sexuels ? »
 - « Est-ce que vous avez eu ces rapports avec la même personne ? »
 - « Y a-t-il une difficulté dont vous souffrez ? »
- Si motif de consultation :
 - Reformuler
 - (Localiser)
 - Qualité
 - Définir la chronologie: date d'apparition, constance
 - Conditions de survenue: « Comment le problème se manifeste-t-il ? »
 - Facteurs modifiant le symptôme: facteurs aggravants ou améliorants
 - Manifestations associées
- Aspects psychosociaux :
 - Perception: aborder le ressenti et déterminer la représentation individuelle

- « Que pensez-vous de ce problème ? »
- « Quels sont les sentiments que vous éprouvez, lorsque qu'on parle de sujet ? »
- Répercussions:
 - « Qu'en pense votre/vos partenaire/s ? »
 - « Quel est l'impact sur la vie quotidienne ? »
- Ressources et motivations
 - « Avez déjà été confronté à ce genre de problèmes ? »
 - « Avez-vous déjà cherché de l'aide ? »
 - « Avez-vous pris des médicaments ? »
 - « Pourquoi consultez-vous maintenant ? Quelles sont vos attentes ? »
- Troubles:
 - Désir :
 - Trouble sexuel le plus fréquent
 - Chez la femme: après la naissance; chez l'homme: dans le contexte d'un burnout
 - « Comment se porte votre libido ? »
 - « Est-ce que vous avez (toujours) envie/désirez avoir des rapports sexuels ? »
 - Excitation :
 - Chez la femme: manque de lubrification (12-30%), incidence augmente avec l'âge, lors de la ménopause, douleurs (dyspareunie)
 - Chez l'homme: difficultés d'érection, 40-50 ans: 10%, 50-60 ans: 15%, 60-70: 35%, 70-80 ans: 50%, maladies somatiques sous-jacentes, troubles psychiatriques, effets médicamenteux
 - « Est-ce que vous êtes (toujours) excité à l'idée d'avoir des rapports sexuels ? »
 - Plaisir :
 - Dyspareunie, vaginisme (contraction musculaire prolongée)
 - « Est-ce que vous êtes satisfaite de vos relations sexuel/sexualité ? »
 - « Est-ce que vous prenez du plaisir lors des rapports sexuels ? »
 - « Est-ce que vous ressentez une douleur/ une souffrance / une gêne lors de vos rapport ? »
- Questionnement sur orientation sexuelle :
 - « Comment ça se passe avec votre/vos partenaire/s ? »
 - Si le patient n'est pas exhaustif, il ne faut pas laisser qu'un climat d'incertitude s'installe. Il faut poser la question directement: « Quelle est votre orientation sexuelle ? »
- Maladies, traitement, dépendances :
 - « Est-ce que vous souffrez de maladies ayant une influence sur votre sexualité ? »
 - « Est-ce que vous avez été traités pour des MST ? »
 - « Est-ce que vous utilisez des moyens de contraception ? »
 - Responsabiliser la personne sur les moyens de contraception : « N'oubliez-pas d'utiliser un préservatif ! »
 - Si la personne éprouve une honte ou une gêne, se focaliser sur ce sentiment et non pas sur les détails (du rapport sexuel). Montrer son soutien et rediriger vers un spécialiste tout en précisant sa disponibilité : « C'est difficile, je comprends. »
 - « Personne n'est parfait. »
- Vécus traumatiques de la sexualité :
 - « Est-ce que vous avez eu une mauvaise expérience avec la sexualité ? »
 - « Est-ce que vous avez pratiqué des comportements à risque ? »
 - « Est-ce que vous avez subis des rapports sans votre consentement ? »
- Difficulté dans les relations sentimentales et violence conjugale :
 - « Est-ce que vous avez été/êtes violenté/abusé par votre partenaire ? »

- Conclusion :
 - « Je peux, si vous le souhaitez, vous rediriger vers un de mes collègues qui pourra vous apporter un soutien psychologique. Mais, dans tous les cas, je reste une personne de référence et je serai toujours à votre disposition ».

CONSEILLÉ	PAS CONSEILLÉ
Créer un climat accueillant pour inviter le patient à se confier	Supposer que tous les patients gays en font part à leur médecin
Le comportement sexuel n'est pas indicatif nécessairement de l'identité sexuelle	Présumer qu'un comportement sexuel définit l'identité de la personne
Utiliser le langage et la terminologie des patients. Certaines personnes ne se définissent pas comme "gay" même en ayant des rapports sexuels avec des partenaires du même sexe	Utiliser le terme "gay" pour décrire un patient qui dit avoir des partenaires du même sexe
Ne pas faire de généralisations trop simplistes sur les besoins de chacun. La population gay n'est pas homogène, même si elle constitue une même communauté	Prétendre que son patient gay a les mêmes besoins que les autres gays
Trouver une occasion favorable pour parler avec le patient de son état sérologique (VIH et IST) et ainsi aborder avec lui les différentes stratégies de prévention et de réduction des risques	Présumer de l'état sérologique du patient ainsi que de la connaissance qu'il a des IST Oublier de réactualiser les connaissances de la personne
Impliquer le patient dans le processus décisionnel et voir avec lui la démarche d'accès aux différents tests	Prescrire systématiquement le test VIH et d'autres tests à un patient sous prétexte qu'il est gay
Etre attentif au langage qu'on utilise pour qu'il soit le plus approprié possible	Présumer que son patient se sent à l'aise avec des termes comme "partenaire actif" et "partenaire passif"
S'assurer que le patient a ou non des enfants	Présumer que le patient n'a pas d'enfants

Guide pratique santé gay par l'association des médecins gays:

<http://www.medecins-gays.com/nos-actions/actions/guide-pratique-sant%C3%A9-gay/>